

低血糖症临床路径

(2016年版)

一、低血糖症标准住院流程

(一) 适用对象。

反复发作低血糖患者

(二) 诊断依据。

Whipple三联征：

1. 禁食或活动后诱发低血糖发作
2. 低血糖症状可用葡萄糖迅速缓解
3. 发作时成人血糖低于 2.8mmol/L

(三) 进入路径标准。

反复院外低血糖而原因未明者

(四) 标准住院日。

7-14天

(五) 住院期间的检查项目。

1. 必需的检查项目

(1) 血常规、尿常规、大便常规。

(2) 血糖、胰岛素、c肽、糖化血红蛋白、糖化白蛋白、甲状腺激素、血性激素全项、ACTH—皮质醇节律、24小时尿游离皮质醇，24小时尿VMA、血胰岛素样生长因子-1，低血糖发作时静脉血糖、胰岛素、c肽，胰岛素自身抗体、肝肾

功能、电解质A+B、出凝血功能及24小时尿电解质。

(3) 胰腺CT (平扫+增强) 或磁共振、AFP、CEA、CA199。

2. 根据患者病情进行的检查项目: PTH、胃泌素、血胰岛素样生长因子结合蛋白、血胰高糖素检查, 经食管胰腺彩超、甲状腺彩超、胰腺彩超、奥曲肽显像、胰高糖素样肽受体显像技术。必要时行OGTT延长法、饥饿试验。

(六) 治疗方案的选择。

手术或者药物治疗

对应升糖激素替代

治疗原发病 (肿瘤切除)

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机。

合并感染时

(八) 手术日。

无

(九) 术后恢复。

无

(十) 出院标准。

明确病因建议下一步外科治疗, 或制定药物治疗方案
出院时监测无低血糖发作

(十一) 变异及原因分析。

明确低血糖是非胰岛素瘤原因造成, 可接受增加住院天

数。因低血糖发生心脑血管急性并发症可增加住院天数

二、低血糖症临床路径表单

适用对象：**第一诊断为**低血糖症待查（ICD-10：_____）；行_____术

患者姓名：_____性别：_____年龄：_____门诊号：_____住院号：_____

住院日期：____年__月__日 出院日期：____年__月__日 标准住院日：____天

时间	住院第1天	住院第2—6天	住院第7—14天
诊疗工作	☐ 检查评估 ☐ ☐ 护理常规：内科 ☐ 护理级别：一/二级护理 ☐ 普食 ☐ 合并症治疗 ☐ 监护	☐ 检查评估 ☐ 血糖、胰岛素、c 肽、糖化血红蛋白、甲状腺激素、血性激素全项、ACTH—皮质醇节律、24 小时尿游离皮质醇，24 小时尿 VMA、血胰岛素样生长因子-1 ☐ 低血糖发作时静脉血糖、胰岛素、c 肽，胰岛素自身抗体、电解质 A+B、出凝血功能、胰腺 CT（平扫+增强）或磁共振、AFP、CEA、CA199 ☐ 经食管胰腺彩超、甲状腺彩超、PTH、胃泌素、胰腺彩超、必要时行 OGTT 延长法、饥饿试验 ☐ 奥曲肽显像、胰高糖素样肽受体显像技术	☐ 检查评估 ☐ 确定治疗方案 ☐ 如拟手术制定术前准备方案
重点医嘱	长期医嘱： ☐ 对症处理 ☐ 监测血糖 临时医嘱： ☐ 完善低血糖相关检查 ☐ 血、尿、粪便常规+潜血检查 ☐ 肝肾功能、电解质、血脂、心肌酶、糖化血红蛋白、术前免疫八项 ☐ AFP、CEA、CA199	长期医嘱： ☐ 对症处理 ☐ 监测血糖 临时医嘱： ☐ 完善低血糖相关检查	长期医嘱： ☐ 对症处理 ☐ 监测血糖 临时医嘱： ☐ 完善低血糖相关检查
护理工作	☐ 宣教		☐ 出院宣教
变异	☐ 无 ☐ 有，原因：	☐ 无 ☐ 有，原因：	☐ 无 ☐ 有，原因：

护士 签名			
医师 签名			